Uveítis en artritis idiopática juvenil: ¿suspender el metotrexato aumenta el riesgo?

Amar Muñoz HM, Clemente D, Boteanu A, et al. Risk of chronic uveitis onset is increased in juvenile idiopathic arthritis in the absence of methotrexate therapy. *Reumatol Clin*. 2026;22:502221. doi:10.1016/j.reumae.2026.502221

Versión 1.0 · Revisado el 31 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

No; refuerza la vigilancia

Apoya mantener la revisión oftalmológica estrecha después de suspender el metotrexato en pacientes de alto riesgo, algo ya razonable.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Débil

Retrospectivo, sin diferencia significativa en el análisis principal; el único hallazgo significativo a favor de la hipótesis de la suspensión se basa en 7 pacientes.

CUIDADO AL INTERPRETAR

El título dice más que los datos

Los propios autores aclaran que sus hallazgos no apoyan una relación causal.

En 30 segundos. Cohorte retrospectiva de 3 hospitales de Madrid: 404 niños con AIJ, de los cuales **77 (19 %)** desarrollaron uveítis, sobre todo anterior crónica, con una mediana de **1.7 años** desde el diagnóstico de AIJ. En el análisis pareado (62 con uveítis y 62 sin ella, por subtipo, edad al diagnóstico, ANA y HLA-B27), la exposición a metotrexato en los primeros 2 años fue **82 % frente a 91 % (p = 0.14), sin diferencia significativa**. Entre quienes suspendieron el metotrexato antes de la uveítis, esta apareció a una mediana de 1.7 años tras la suspensión. Al diagnóstico de uveítis, la mayoría no recibía tratamiento sistémico.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cohortes retrospectivas y confusión por indicación: por qué el grupo con uveítis recibió *más* metotrexato alguna vez, qué limita un pareamiento sin controles aleatorios, por qué "no significativo" no es "sin efecto" (ni "con efecto"), cómo leer un subgrupo de 7 pacientes y qué hacer cuando el resumen y el texto no coinciden.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Menores de 16 años con AIJ (criterios ILAR) de 3 hospitales de Madrid. Para el pareamiento solo se usaron oligoartritis y poliartritis con FR negativo; se excluyeron sistémica, psoriásica, indiferenciada, relacionada con entesitis y poliartritis con FR positivo por su bajo riesgo.
EXPOSICIÓN	Metotrexato (inicio, duración y suspensión) y tratamiento sistémico al momento de la uveítis.
COMPARADOR	AIJ sin uveítis, pareados 1:1 por distancia de Mahalanobis (subtipo, edad al diagnóstico, ANA, HLA-B27), con seguimiento al menos similar. Los controles no se eligieron al azar.
DESENLACE	Aparición de uveítis (confirmada por oftalmología pediátrica, criterios SUN) y tiempo desde la suspensión del metotrexato.

2 Diseño

TIPO	Observacional, retrospectivo, longitudinal y multicéntrico (expedientes clínicos).
ANÁLISIS	Análisis pareado (funciona como casos y controles anidado) ajustado por ANA, edad y subtipo; solo se reportan valores de p, sin medidas de efecto ni IC. Curvas de Kaplan-Meier para el tiempo a la uveítis; prueba exacta de Fisher en el subgrupo de inicio tardío. No se analizó la dosis de metotrexato (datos incompletos) ni la actividad de la enfermedad (cJADAS). Exposición a metotrexato: al menos 3 meses continuos; al inicio de la uveítis no contaban como tratamiento sistémico los AINE, esteroides tópicos, ciclos cortos de esteroide oral ni infiltraciones.
FINANCIAMIENTO	Sin financiamiento específico; sin conflictos de interés declarados. Apoyo editorial de la Fundación Española de Reumatología.

3 Resultados

HALLAZGO	RESULTADO
Uveítis en la cohorte	77/404 (19 %); 90 % anterior crónica; 52 % bilateral; 11 con al menos una complicación (el artículo reporta 18.2 %; 11/77 = 14 %); 2 con ceguera por uveítis refractaria
Tiempo del diagnóstico de AIJ a la uveítis	Mediana 1.7 años (RIC 0.42 a 3.65); 37.5 % en el primer año
Metotrexato alguna vez (cohorte completa)	96.1 % con uveítis frente a 86 % sin uveítis (p = 0.017); anti-TNF alguna vez 83.1 % frente a 53 % (p <0.001). En los pareados, metotrexato alguna vez 98 % frente a 94 % (p = 0.4)
Metotrexato en los primeros 2 años (pareados, 62 vs 62)	**82 % frente a 91 % (p = 0.14), sin diferencia significativa**
Duración del metotrexato hasta suspenderlo (pareados)	2.8 frente a 2.05 años (p = 0.12)
Uveítis después de suspender el metotrexato	19 pacientes (24.7 %); mediana desde la suspensión 1.7 años (RIC 0.89 a 3.7)
Uveítis tardía (>7 años del diagnóstico)	7 pacientes (9.7 %): 5 de 7 habían suspendido el metotrexato antes, frente a 13 de 71 con uveítis más temprana (p = 0.007)
Tratamiento al diagnóstico de la uveítis	Sin tratamiento sistémico 57.1 % (44), metotrexato 31.2 %, etanercept 7.8 %, ambos 3.9 % (un párrafo de Resultados dice 46.8 %)

4 Cómo leer estos resultados

- **El análisis principal no fue significativo.** DATO DEL ARTÍCULO En los pareados, 82 % frente a 91 % de exposición temprana a metotrexato (p = 0.14). INTERPRETACIÓN No demuestra que el metotrexato proteja ni que no lo haga: el estudio no tuvo poder suficiente, como reconocen los autores.
- **Confusión por indicación y temporalidad.** En la cohorte completa, quienes tuvieron uveítis habían recibido metotrexato alguna vez con *más* frecuencia (96 % frente a 86 %). INTERPRETACIÓN No significa que el fármaco cause uveítis: la cifra incluye metotrexato recibido en cualquier momento, también después de la uveítis (como tratamiento de ella), y compara subtipos distintos; a los niños de más riesgo además se les indica más. En el análisis pareado la diferencia desaparece (98 % frente a 94 %).
- **El hallazgo a favor de la suspensión es de 7 pacientes.** En la uveítis tardía, 5 de 7 habían suspendido el metotrexato. Con números tan pequeños, el resultado es frágil. INTERPRETACIÓN Además, quien debuta con uveítis después de 7 años de enfermedad ha tenido más tiempo para completar y suspender el metotrexato (la mayoría lo suspende por remisión), así que esa diferencia se espera aunque no haya relación causal.
- **El "periodo de 18 meses" no cuadra del todo.** DATO DEL ARTÍCULO Los autores proponen vigilar cada 3 meses durante los 18 meses posteriores a suspender el metotrexato, pero la mediana desde la suspensión fue de 1.7 años (~20 meses) y la mitad de los casos ocurrió entre ~11 meses y 3.7 años. INTERPRETACIÓN Con su propia mediana, una ventana de 18 meses captaría menos de la mitad de los casos; una vigilancia más prolongada en alto riesgo sería más coherente con sus datos.
- **Inconsistencias internas.** El porcentaje sin tratamiento sistémico al diagnóstico de la uveítis es 57.1 % (44 pacientes) en el resumen y en Resultados, y 46.8 % en otro párrafo; el 57.1 % es el que cuadra con los conteos. Los porcentajes de exposición temprana no corresponden a 62 por grupo (50/62 = 81 %, 52/62 = 84 %), y algunos conteos no suman (7 + 71 = 78 casos).

CONCEPTO CLAVE · CONFUSIÓN POR INDICACIÓN

INTERPRETACIÓN Ocurre cuando el motivo por el que se indica un tratamiento también se relaciona con el desenlace. En estudios observacionales, los pacientes tratados suelen ser los más graves, y el tratamiento parece "asociarse" a peor evolución. El pareamiento ayuda solo con las variables que se usan para parear (aquí, subtipo, edad, ANA y HLA-B27); no corrige la gravedad, la actividad de la enfermedad ni las decisiones del médico, que no se midieron. Por eso un estudio así puede generar hipótesis, pero no establecer causalidad: lo dicen los propios autores.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Uveítis confirmada	Diagnóstico por oftalmología pediátrica con criterios SUN.	Confirmado
● Multicéntrico	Tres hospitales; 404 pacientes con AIJ.	Confirmado
● Retrospectivo	Posible sesgo de selección (reconocido por los autores) y de información (interpretación).	Reconocido / interpretación
● Poder estadístico	Insuficiente para confirmar la asociación.	Reconocido por los autores
● Pareamiento incompleto	Se parearon 62 de 77; los 15 no pareados coinciden con los subtipos excluidos (el artículo lo atribuye a falta de control adecuado). Controles no aleatorios.	Dato del artículo
● Variables no medidas	Dosis de metotrexato y actividad de la enfermedad (cJADAS) no analizadas.	Reconocido por los autores

Aplicabilidad	Solo oligoartritis y poliartritis con FR negativo en el análisis pareado.	Reconocido por los autores

Pregunta de repaso: niña de 7 años con oligoartritis persistente ANA positiva, en remisión con metotrexato desde hace 2 años. La familia quiere suspenderlo. ¿Qué agrega este estudio?
Respuesta. No demuestra que suspender el metotrexato cause uveítis, pero sugiere que la uveítis puede aparecer años después de la suspensión, incluso con enfermedad de larga evolución, en niñas con este perfil de riesgo. Si se suspende, conviene mantener la revisión oftalmológica estrecha (los autores proponen cada 3 meses) y no relajarla demasiado pronto: entre quienes presentaron uveítis tras suspender, la mediana fue de ~20 meses. El estudio no informa qué proporción de quienes suspendieron desarrolló uveítis.

¿Qué aprendí de medicina?

- ~1 de cada 5 niños con AIJ desarrolló uveítis en esta cohorte.
- La mayoría aparece en los primeros 3 años, pero puede ser tardía.
- Tras suspender el metotrexato: vigilancia oftalmológica estrecha.
- Mayor riesgo (literatura): niñas, inicio temprano, oligoartritis, ANA+; aquí fueron significativos la edad de inicio y ANA+.

¿Qué aprendí de investigación?

- Confusión por indicación: el tratado suele ser el más grave.
- Parear no corrige lo que no se midió.
- p = 0.14 no prueba ausencia de efecto.
- Un subgrupo de 7 pacientes es frágil.

6 Referencias

1. Amar Muñoz HM, Clemente D, Boteanu A, et al. Risk of chronic uveitis onset is increased in juvenile idiopathic arthritis in the absence of methotrexate therapy. Reumatol Clin. 2026;22:502221. doi:10.1016/j.reumae.2026.502221

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.